

CRISE DE ASMA



ROTINA CLÍNICA

Modelos de evolução

ANAMNESE

- **HDA:**

PACIENTE RELATA QUADRO DE DISPNEIA, SENSÇÃO DE OPRESSÃO TORÁCICA E SIBILÂNCIA COM INÍCIO HÁ.
NEGA OUTRAS QUEIXAS.

- **HPP:**

ALERGIAS:

COMORBIDADES:

TABAGISMO/ETILISMO:

- **MEDICAÇÕES EM USO DOMICILIAR:**



EXAME FÍSICO

GERAL: REG, NORMOCORADA, HIDRATADA, ACIANÓTICA, ANICTÉRICA E AFEBRIL.

NEURO: LOTE, GLASGOW 15, SEM DÉFICITS FOCAIS APARENTES, PUPILAS ISOCÓRICAS E FOTORREAGENTES, SEM SINAIS DE IRRITAÇÃO MENÍNGEA.

AR: MVF+, SIBILOS EXPIRATÓRIOS DIFUSOS, EUPNEICA EM AR AMBIENTE, SAT.O₂: %, SEM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO.

ACV: RCR, 2T, BNF, S/ SOPROS, FC: BPM, PA: MMHG, TEC < 3 SEGUNDOS.

ABD: ATÍPICO, RHA +4Q, TIMPÂNICO, FLÁCIDO, INDOLOR À PALPAÇÃO SUPERFICIAL E PROFUNDA, NÃO PALPO MASSAS E/OU VISCEROMEGALIAS.

MMII: SEM EDEMAS, SEM EMPASTAMENTO DE PANTURRILHAS.



HD E CONDOTA

- **HIPÓTESE DIAGNÓSTICA:**

CRISE DE ASMA (LEVE/MODERADA OU GRAVE)

- **CONDUTA:**

- PRESCREVO MEDIDAS PARA BRONCOESPASMO AGORA
- PRESCREVO CORTICOIDE ORAL/PARENTERAL
- REAVALIAÇÃO APÓS MEDIDAS
- FORNEÇO RECEITA MÉDICA
- FORNEÇO ATESTADO MÉDICO
- ORIENTO ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL
- ORIENTO SOBRE SINAIS DE ALARME (INCLUINDO: DISPNEIA E RECORRÊNCIA DOS SINTOMAS DE BRONCOESPASMO), E, EM CASO DE PRESENÇA DESTES, DEVE PROCURAR ATENDIMENTO MÉDICO.



DETALHAMENTO

- **SEMPRE** ESTRATIFICAR A EXACERBAÇÃO CONFORME SUA GRAVIDADE:
- **LEVE:** PACIENTE FALA SENTENÇAS, É CAPAZ DE DEITAR, TAQUIPNEICO (PORÉM < 30 IRPM), **SEM USO DE MUSCULATURA ACESSÓRIA** (NORMALMENTE), SIBILOS EXPIRATÓRIOS MODERADOS, FC < 100 BPM, AGITADO OU SEM ALTERAÇÃO DO ESTADO MENTAL, **SAT.O2 > 94/95%**.
- **MODERADA:** DISPNEIA AO FALAR, FALA APENAS FRASES, TAQUIPNEICO (PORÉM < 30 IRPM), **USO DE MUSCULATURA ACESSÓRIA**, SIBILOS EXPIRATÓRIOS DIFUSOS, FC 100 – 120 BPM, AGITADO, **SAT.O2: 91 – 95%**.



DETALHAMENTO

- **GRAVE:** DISPNEIA AO REPOUSO, FALA **APENAS PALAVRAS**, INCAPAZ DE DEITAR, **TAQUIPNEICO** ($FR > 30$ IRPM), **USO DE MUSCULATURA ACESSÓRIA**, SIBILOS INSPIRATÓRIOS E EXPIRATÓRIOS, **FC > 120 BPM**, AGITAÇÃO E **SAT.O2 $< 90\%$** .
- **EMINÊNCIA DE PCR:** INCAPAZ DE FALAR, RESPIRAÇÃO PARADOXAL, **TÓRAX SILENCIOSO**, BRADICARDIA, CONFUSÃO MENTAL OU SONOLÊNCIA.

